

一、疾病理解與病理機轉

急性呼吸衰竭是指身體無法順利吸入足夠氧氣或排出二氧化碳,導致血液中氧氣太低或二氧化碳太高,這可能是因為大腦、肺部、氣道或肌肉任何一個環節出了問題。例如大腦水腫會影響呼吸中樞功能,即使肺部本身沒有問題,也會導致呼吸型態改變甚至呼吸停止。心衰竭則是心臟無法有效輸送足夠血液與氧氣到全身,無法滿足身體需求,造成呼吸喘、疲倦無力、下肢水腫等症狀。這兩種狀況都會嚴重影響身體重要器官的功能。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 抗生素、類固醇、支氣管擴張劑等藥物需按醫囑規律服用,不可自行停藥。
2. 心衰竭藥物如利尿劑、乙型交感神經阻斷劑需每天定時服用,幫助減輕心臟負擔。
3. 降尿酸藥物需要每天規律服用,不可只在痛風發作時才吃。
4. 所有藥物都應按照醫師指示的劑量和時間服用,不要自行調整。
5. 如果忘記服藥,請諮詢醫師或藥師該如何補服,不要自行加倍劑量。

三、警訊辨識與處置行為

1. 呼吸急促、喘不過氣、嘴唇發紫時應立即就醫。
2. 意識混亂、昏沉或叫不醒時需緊急送醫。
3. 痰變得又黃又濃且咳不出來,伴隨發燒超過38.5°C應返院。
4. 一日體重增加1公斤或一周增加2公斤以上需警覺。
5. 下肢水腫加劇、呼吸困難加重、無法平躺時應立即求診。
6. 肌肉無力及麻痺、口唇發麻可能是高血鉀急症,需緊急處理。

四、飲食與活動建議

1. 限制液體及鹽分攝取,每日鹽分控制在2-4公克。
2. 蔬菜先用大量水煮3-5分鐘再烹調,減少鉀含量,避免喝菜湯。
3. 避免高鉀食物如香蕉、榴槤、番茄、巧克力、堅果類。
4. 戒菸戒酒,避免油炸、高脂肪食物和刺激性飲食。
5. 餐後1-2小時內避免平躺,睡覺時頭部抬高15-25公分。
6. 適度活動促進血液循環,但嚴重時應臥床休息減少心臟負擔。
7. 每週5-7天進行30分鐘以上有氧運動,維持理想體重。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 每日測量並記錄血壓、脈搏、體重變化,回診時提供醫師參考。
2. 定期回門診追蹤檢查,包括血液檢查、心電圖、胸部X光等。
3. 規律接受透析治療(如需洗腎),這是排除鉀離子的重要管道。
4. 配合營養師設計個人化飲食計畫,控制水分、鉀、磷攝取。
5. 出現任何不適症狀或藥物副作用時,立即聯繫醫療團隊。

6. 保持穩定情緒和充足睡眠,適度休閒活動增加人際互動。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 思覺失調症(ICD-10: F200)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 規律服用抗精神病藥物(約4週才能達到緩解效果),即使症狀消失也不可自行停藥。
- 家屬應協助督促服藥並留意病情變化;出現傷害自己或他人行為時需立即就醫。
- 定期回身心科門診,配合醫療團隊追蹤治療進展。

■ 高血壓(ICD-10: I129)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

■ 慢性腎臟病(ICD-10: N189)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 採低磷、低鉀飲食(視腎功能分期調整),蔬菜煮熟後倒掉湯汁可降低鉀含量。
- 嚴格限制液體及鹽分攝取,避免使用止痛藥(NSAIDs)或來路不明的中草藥。
- 定期回診追蹤腎功能(尿素氮、肌酸酐、電解質),準時接受透析治療(若需要)。

■ 重度憂鬱症(ICD-10: F329)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 規律服用抗憂鬱藥物,通常需數週才有效果,不可自行停藥;如有副作用請告知醫師。
- 維持規律作息與適度運動(每週3~5次),多接觸陽光,配合心理治療。
- 出現傷害自己或他人的念頭時,這屬於緊急狀況,請立即就醫或撥打緊急電話。

■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 逆流性食道炎(ICD-10: K219)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 飯後不立即平躺,睡前2小時避免進食;抬高床頭約15公分可減少夜間逆流。
- 避免油膩、辛辣、巧克力、咖啡、酒精等刺激性食物。
- 按醫師指示服用制酸劑或質子幫浦抑制劑,即使症狀消失也需依醫囑完成療程。

■ 高尿酸血症/痛風(ICD-10: M109)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 急性發作時,患部冰敷、抬高並休息;遵醫囑使用秋水仙素或類固醇緩解疼痛。
- 少吃紅肉、內臟、海鮮、啤酒等高嘌呤食物;腎功能允許時每日飲水 > 2000 mL。
- 長期降尿酸藥物(Allopurinol 或 Febuxostat)需規律服用,目標尿酸 < 6 mg/dL。

七、參考衛教手冊

1. 急性呼吸衰竭
2. 靜脈注射輸液之護理指導
3. 心衰竭
4. 動靜脈瘻管照護(印文版)
5. 逆流性食道炎護理指導
6. 準備低鉀飲食
7. 高血鉀症
8. 思覺失調症
9. 輸血治療之護理指導
10. 憂鬱症
11. 高血壓
12. 末期腎臟疾病
13. 高血脂症護理指導
14. 痛風護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31